

CAD NA GESTANTE — TRATAR A MÃE SALVA O FETO

PARTICULARIDADES DA CAD NA GESTAÇÃO

Aspecto	Detalhe
CAD euglicêmica	Pode ocorrer com glicemia NORMAL ou pouco elevada (< 200) — não excluir CAD pela glicemia
Instala-se mais rápido	A gestação favorece a cetose (jejum acelerado, resistência insulínica) — CAD em níveis glicêmicos menores
Risco fetal	Alta mortalidade fetal; a acidose materna reduz a perfusão e oxigenação placentária
Gatilhos	Infecção, vômitos (hiperêmese), corticoide (maturação pulmonar), beta-agonista (tocólise), má adesão
Diagnóstico	Acidose metabólica com GAP elevado + cetose + hiperglicemia (que pode ser leve)
Princípio	TRATAR A MÃE é a melhor forma de proteger o feto — corrigir a acidose materna

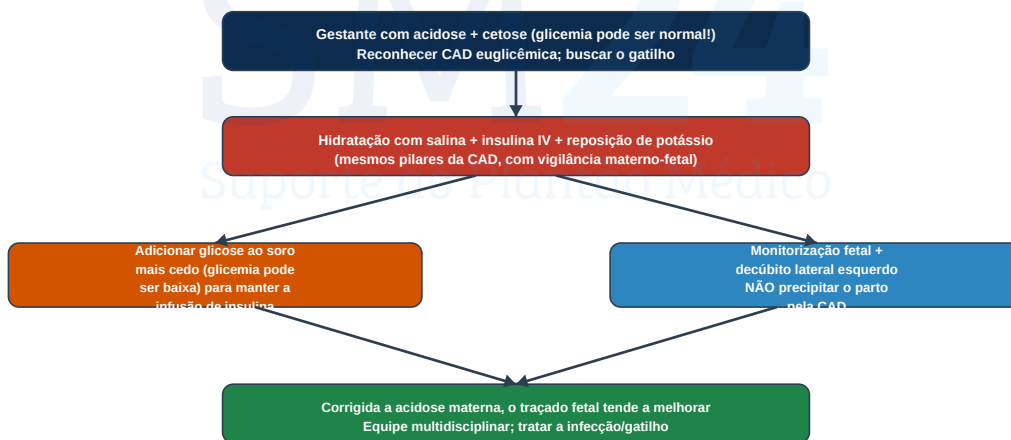
PRINCÍPIO CENTRAL: ESTABILIZAR A MÃE

NÃO INDICAR PARTO DE EMERGÊNCIA SÓ PELO SOFRIMENTO FETAL DA CAD

- A CAD materna causa sofrimento fetal (cardiotocografia alterada) que costuma MELHORAR com a correção da acidose materna
- Não interromper a gestação precipitadamente por traçado fetal não tranquilizador durante a CAD — primeiro estabilizar a mãe
- Operar uma gestante acidótica e instável aumenta o risco materno e fetal
- Monitorização fetal contínua (se viável) durante o tratamento; decúbito lateral esquerdo
- Tratar agressivamente o gatilho (infecção, vômitos) e corrigir fluidos/insulina/potássio
- Equipe multidisciplinar (obstetrícia + clínica/endócrino + UTI)

MANEJO DA CAD NA GESTANTE

CAD GESTANTE — FLUIDO, INSULINA, K, FETO



TRATAMENTO — PILARES (ADAPTADOS À GESTAÇÃO)

Rx FLUIDO, INSULINA, POTÁSSIO, GLICOSE

Hidratação: salina 0,9% vigorosa (corrigir a desidratação, que é importante na gestante)

Insulina regular IV em infusão contínua (0,1 U/kg/h), após checar e corrigir o potássio

Potássio: repor para manter 4-5 mEq/L; se K < 3,3 repor ANTES da insulina

Glicose: associar soro glicosado mais precocemente (a glicemia pode ser baixa - CAD euglicêmica) para manter a insulina até resolver a cetose

Tratar o gatilho: antibiótico se infecção; controlar os vômitos da hiperêmese

Cuidado com corticoide (maturação fetal) e beta-agonista (tocólise) — podem precipitar/agravar a CAD

Bicarbonato apenas em acidose muito grave (pH < 6,9), como na CAD não gestante

GATILHOS E BEM-ESTAR FETAL

Gatilhos na Gestação

- Infecção (ITU, pielonefrite — comum na gestante)
- Hiperêmese gravídica (vômitos, jejum)
- Corticoide para maturação pulmonar fetal (betametasona)
- Beta-agonista para tocólise
- Má adesão/omissão de insulina
- Diabetes gestacional descompensado ou DM prévio

Cuidados com o Feto

- Monitorização fetal contínua quando viável (idade gestacional)
- Decúbito lateral esquerdo (melhora o retorno venoso e a perfusão uteroplacentária)
- Otimizar oxigenação e volemia maternas
- Traçado não tranquilizador costuma melhorar com a correção da acidose
- Decisão de parto: individualizada, após estabilização materna
- Equipe obstétrica + UTI

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Suspeitar de CAD na gestante mesmo com glicemia normal (CAD euglicêmica)
- ☐ Pilares: hidratação + insulina IV + reposição de potássio (corrigir K < 3,3 antes da insulina)
- ☐ Associar glicose ao soro mais precocemente (glicemia pode ser baixa)
- ☐ Tratar o gatilho (infecção, vômitos) e rever corticoide/beta-agonista
- ☐ Monitorização fetal + decúbito lateral esquerdo; NÃO precipitar o parto pela CAD
- ☐ Estabilizar a mãe corrige a acidose e melhora o feto; equipe multidisciplinar

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Gestante diabética com vômitos, acidose metabólica com GAP elevado e cetose, mas glicemia de 180 mg/dL. Qual a interpretação?

- A) CAD está excluída pela glicemia normal
- B) Pode ser CAD euglicêmica — a gestação favorece cetoadidose com glicemia normal ou pouco elevada
- C) É apenas hiperêmese sem repercussão
- D) É cetoadidose alcoólica
- E) É EHH

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Durante o tratamento da CAD em gestante, a cardiotocografia mostra traçado não tranquilizador. Qual a conduta?

- A) Cesárea de emergência imediata
- B) Estabilizar a mãe (corrigir a acidose, fluidos, insulina); o traçado fetal tende a melhorar com a correção materna
- C) Suspender a insulina
- D) Administrar tocolítico beta-agonista
- E) Interromper a hidratação

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Por que se deve associar glicose ao soro mais precocemente na CAD da gestante?

- A) Para elevar a glicemia rapidamente
- B) Porque a glicemia pode estar baixa (CAD euglicêmica) e a insulina precisa ser mantida até resolver a cetose
- C) Para suspender a insulina
- D) Para tratar a infecção
- E) Para reduzir o potássio

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Quais intervenções obstétricas podem PRECIPITAR ou agravar a CAD na gestante?

- A) Repouso e hidratação
- B) Corticoide para maturação pulmonar fetal e beta-agonista para tocolise
- C) Decúbito lateral esquerdo
- D) Monitorização fetal
- E) Antibiótico para ITU

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual é o princípio central do manejo da CAD na gestação em relação ao feto?

- A) Interromper a gestação assim que houver sofrimento fetal
- B) Tratar e estabilizar a mãe (corrigir a acidose) é a melhor forma de proteger o feto
- C) Priorizar o parto sobre a correção metabólica
- D) Manter a mãe em jejum prolongado
- E) Evitar a insulina pelo risco fetal

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Na gestação pode ocorrer CAD euglicêmica — acidose com GAP elevado e cetose mesmo com glicemia normal ou pouco elevada. Não se deve excluir CAD pela glicemia; a gestação favorece a cetose por jejum acelerado e resistência insulínica.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O sofrimento fetal na CAD materna decorre da acidose e da redução da perfusão placentária e tende a MELHORAR com a estabilização materna. Não se deve indicar cesárea de emergência precipitada — primeiro corrigir a acidose, fluidos e insulina da mãe.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Como a glicemia pode estar baixa (CAD euglicêmica), associa-se glicose ao soro mais precocemente para permitir a manutenção da infusão de insulina (necessária para resolver a cetose) sem causar hipoglicemia.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O corticoide para maturação pulmonar fetal (betametasona) e os beta-agonistas usados na tocolise elevam a glicemia e a resistência insulínica, podendo precipitar ou agravar a CAD na gestante diabética — exigem monitorização rigorosa.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O princípio central é que tratar e estabilizar a MÃE (corrigir a acidose, a desidratação e os distúrbios) é a melhor forma de proteger o feto. A interrupção precipitada da gestação durante a CAD aumenta os riscos materno e fetal.

SM24
Suporte ao Plantão Médico